

## Cochez- la ou les bonnes réponses

1. Quelle est la principale préoccupation de la démographie ?
  - A. L'étude des comportements individuels
  - B. L'éducation des populations à besoins spécifiques
  - C. L'étude des populations humaines
  - D. La recherche médicale
2. Quel aspect de la population les démographes étudient-ils principalement ?
  - A. La qualité de vie
  - B. La dimension, la structure et l'évolution
  - C. Les politiques publiques
  - D. Les préférences culturelles
3. La démographie envisage principalement les caractéristiques des populations sous quel angle ?
  - A. Qualitatif
  - B. Psychologique
  - C. Historique
  - D. Quantitatif
4. Que désigne le terme "migration spatiale" ?
  - A. Le déplacement à l'intérieur d'un même territoire
  - B. Le déménagement entre deux espaces économiques
  - C. Le déplacement simultané entre deux lieux : lieu d'origine et lieu de destination
  - D. L'immigration illégale
5. Comment définit-on la migration nette ?
  - A. Le nombre total de déplacements effectués pendant une période donnée
  - B. La différence entre les entrées et les sorties
  - C. La somme des migrations entrantes et sortantes
  - D. Le flux migratoire moyen sur une année
6. Quelle est la caractéristique principale de la migration interne ?
  - A. Le lieu d'origine et le lieu de destination se trouvent dans des pays différents
  - B. Le lieu d'origine et le lieu de destination se trouvent tous les deux à l'intérieur du même territoire
  - C. La migration interne concerne uniquement les déplacements internationaux
  - D. La migration interne est limitée aux changements de résidence à l'intérieur d'une même ville
7. Qu'est-ce qu'une migration alternante ?
  - A. Un déplacement vers une autre région pendant les vacances
  - B. Des déplacements quotidiens des travailleurs entre le lieu de travail et le lieu de résidence
  - C. Une migration définitive d'un lieu à un autre
  - D. Une migration saisonnière pour des événements spéciaux
8. Quelle est la formule pour calculer le Taux de mortalité infantile (TMI) ?
  - A.  $TMI = \text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée} / \text{Total des naissances vivantes durant cette année.} \times 100$
  - B.  $TMI = \text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée} / \text{Total des naissances vivantes durant cette année.} \times 1.000$
  - C.  $TMI = (\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée} + \text{Total des naissances vivantes durant cette année.}) / 1000$
  - D.  $TMI = (\text{Total des naissances vivantes durant cette année.} - \text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an durant une année donnée}) / 1.000$





9. Comment l'OMS définit-elle la santé publique selon la définition de 1952 ?
  - A. Comme la science et l'art de traiter les maladies à un niveau individuel
  - B. Comme la science et l'art de prévenir les maladies, prolonger la vie, et améliorer la santé physique et mentale à un niveau individuel et collectif
  - C. Comme la gestion des établissements de santé et des services médicaux
  - D. Comme la recherche et le développement de nouveaux médicaments
10. Quel est un des objectifs de la santé publique selon la définition de l'OMS ?
  - A. Augmenter les coûts des soins de santé pour la population
  - B. Réduire le nombre de consultations médicales nécessaires
  - C. Prolonger la vie et améliorer la santé physique et mentale
  - D. Promouvoir exclusivement les traitements médicaux intensifs
11. Comment la santé publique aborde-t-elle généralement les problèmes de santé ?
  - A. En traitant les individus un par un
  - B. En se concentrant uniquement sur les traitements médicaux
  - C. En adoptant une approche de population pour traiter les problèmes de santé
  - D. En fournissant des services de soins intensifs
12. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comment est-ce que la santé est décrite ?
  - A. Comme l'absence de maladie ou d'infirmité
  - B. Comme un état complet de bien-être physique, mental et social
  - C. Comme la capacité à mener une vie active sans limitation
  - D. Comme la présence de forces et d'énergie au quotidien
13. Selon la définition de l'OMS, qu'est-ce qui caractérise une communauté ?
  - A. Un groupe de personnes avec des intérêts financiers communs
  - B. Un groupe de personnes vivant souvent dans une zone géographique bien définie, partageant une culture, des valeurs et des normes
  - C. Un groupe de personnes ayant un statut social élevé
  - D. Un groupe de personnes ayant uniquement des objectifs professionnels communs
14. Selon l'OMS, que désignent les Déterminants Sociaux de la Santé (DS) ?
  - A. Les traitements médicaux spécifiques pour chaque maladie
  - B. Les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que le système mis en place pour faire face à la maladie
  - C. Les politiques de santé publique au niveau national
  - D. Les médicaments disponibles sur le marché
15. Quels sont les différents niveaux de participation de la communauté dans les programmes, selon le degré d'implication ?
  - A. Participation aux avantages des programmes
  - B. Participation aux activités des programmes
  - C. Participation à l'exécution des programmes
  - D. Participation à la planification des programmes
6. L'apparition dans une collectivité humaine d'une maladie dont la fréquence est clairement en excès par rapport à la fréquence attendue :
  - A. Epidémie
  - B. Endémie
  - C. Pandémie
  - D. Cas sporadiques



**17. La Pandémie est un phénomène de masse**

- A. Limité dans le temps et dans l'espace
- B. Limité dans le temps illimité dans l'espace
- C. Limité dans le temps et dans l'espace avec fréquence basse
- D. Illimité dans le temps, limité dans l'espace

**18. La démarche épidémiologique consiste à :**

- A. Mesurer la fréquence d'un phénomène de santé, telle qu'une maladie, d'en faire la distribution selon les caractéristiques de personne, de lieu et de temps
- B. Emettre des hypothèses sur les déterminants de la fréquence d'un phénomène.
- C. Une fois les hypothèses vérifiées, des actions appropriées seront menées pour contrôler voire éliminer le phénomène en question.
- D. Evaluer l'impact des actions implantées sur la fréquence du phénomène de santé.

**19. Les types d'enquêtes utilisées dans les études épidémiologiques analytiques sont :**

- A. Enquêtes cas-témoins
- B. Étude de cohorte prospective (enquête exposés/non exposés)
- C. Enquête analytique transversale
- D. Série de cas

**20. La participation communautaire est :**

- A. Un processus par lequel les individus et les familles, prennent en charge leur propre santé et leur propre bien être comme ceux de la communauté.
- B. La capacité des individus de concourir à leur propre développement comme à celui de communauté.
- C. Mise en œuvre par des professionnels de santé qui planifient seuls leurs actions de santé
- D. L'implication de la population dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de santé

**21. Les clés de réussite de l'action communautaire sont :**

- A. Leadership
- B. La confidentialité
- C. Volontariat
- D. Partenariat et engagement des parties prenantes

**22. La chaîne de transmission de l'infection est composée de:**

- A. l'agent infectieux,
- B. le réservoir,
- C. la porte de sortie, le mode, et la porte d'entrée
- D. l'hôte réceptif.

**23. Le mode de transmission indirect, c'est-à-dire:**

- A. Lorsque le pathogène est transmis par contact étroit entre un sujet infecté et un hôte réceptif ;
- B. Lorsque la transmission s'effectue par l'intermédiaire d'un vecteur (insecte, animal)
- C. Lorsque la transmission s'effectue par l'intermédiaire d'un « véhicule » comme l'eau ou un aliment (cas du choléra, de l'hépatite, de la poliomyélite, etc.).
- D. Le mode de transmission des maladies suivantes (tuberculose, sida, syphilis)

**24. Les vecteurs de transmission du paludisme sont :**

- A. Les phlébotomes femelles
- B. Les anophèles femelles
- C. Les phlébotomes mâles
- D. Les puces





25. Quelle est la particularité essentielle de la Communauté selon l'OMS ?
- A. Une population aux niveaux économiques variés, capable de s'engager dans des projets communautaires
  - B. Un ensemble de personnes engagées dans des activités de santé dans une zone géographique définie
  - C. Un groupe partageant des valeurs et des normes dans une zone géographique définie
  - D. Un groupe de citoyens de la même zone géographique
26. Qu'est-ce qui caractérise une intervention Santé/Environnement à base communautaire par rapport à d'autres initiatives de santé ?
- A. Elle repose sur une analyse des besoins locaux et une implication active de la communauté.
  - B. Elle bénéficie d'un financement mixte, incluant des partenariats publics et privés.
  - C. Elle vise à prévenir à la fois les maladies transmissibles et non transmissibles.
  - D. Elle est adaptée aux contextes urbains et ruraux selon les besoins locaux.
27. Pourquoi l'approche fondée sur le genre est-elle intégrée dans les interventions de santé communautaire ?
- A. Pour garantir que les besoins spécifiques des différents genres soient pris en compte dans les interventions.
  - B. Pour promouvoir les droits des femmes dans les milieux urbains et ruraux
  - C. Pour assurer une distribution équitable des ressources en fonction des besoins de genre.
  - D. Pour garantir l'égalité de participation entre les hommes et les femmes dans la prise de décision
28. Quel type de données est crucial lors de la phase de diagnostic dans un programme santé/environnement communautaire ?
- A. Données sur les déterminants sociaux de la santé
  - B. Données intégrées sur les besoins sanitaires et environnementaux
  - C. Données sur les dynamiques de pouvoir et les relations communautaires
  - D. Données spécifiques aux vulnérabilités environnementales et sanitaires
29. Quel est l'impact attendu de la participation communautaire dans un programme santé/environnement sur les inégalités d'accès aux soins ?
- A. Optimisation des ressources pour les populations vulnérables
  - B. Renforcement des capacités locales pour une meilleure distribution des soins
  - C. Adaptation des services aux besoins spécifiques identifiés par la communauté
  - D. Amélioration des équités en santé par des interventions localisées
30. Quelle est la définition la plus appropriée de l'éthique ?
- A. L'ensemble des règles écrites qui régissent la conduite humaine dans la société.
  - B. L'ensemble des règles de conduite spécifiques à une profession.
  - C. L'ensemble de principes permettant de distinguer le juste de l'injuste.
  - D. Une réflexion argumentée visant à promouvoir le bien-agir.
31. Que fournit l'éthique dans le contexte professionnel ?
- A. Des solutions toutes faites aux problèmes.
  - B. Un éclairage utile pour le raisonnement et les décisions.
  - C. Un ensemble strict de règles à suivre.
  - D. Des réponses définitives à toutes les questions morales.
32. Qu'est-ce qu'une question éthique ?
- A. Une interrogation dont la réponse est définie par la science.
  - B. Un questionnaire sur l'adéquation des soins à prodiguer.
  - C. Une interrogation dont la réponse n'est pas dans le registre « scientifique ».
  - D. Une décision facile à prendre en contexte médical.





33. Comment aborde-t-on une situation éthique en santé communautaire ?
- A. En réfléchissant et en décidant seul.
  - B. En discutant uniquement avec les agents communautaires.
  - C. En réfléchissant en groupe (importance de la pluridisciplinarité).
  - D. En suivant strictement les protocoles établis.
34. Qu'est-ce qu'un dilemme éthique ?
- A. Une situation causant de la détresse morale.
  - B. Une circonstance où deux valeurs éthiques conflictuelles doivent être pesées.
  - C. Une confusion entre choix professionnels et personnels.
  - D. Une simple fatigue émotionnelle due au stress.
35. Quelles qualités caractérisent un infirmier leader ?
- A. Capacité à influencer ses pairs.
  - B. Compétences en jugement professionnel et création de relations.
  - C. Tendance à prendre des décisions unilatérales.
  - D. Orientation strictement vers les objectifs administratifs.
36. Quel est l'objectif principal du partenariat ?
- A. Assurer le financement exclusif des projets de développement
  - B. Gérer les ressources humaines, matérielles ou financières pour exécuter des prestations sociales, réaliser des projets de développement, ou fournir des services d'intérêt collectif
  - C. Fournir uniquement des prestations sociales sans collaboration
  - D. Limiter la mise en commun des ressources à des projets de petite envergure
37. Quels types de ressources sont mises en commun dans un partenariat ?
- A. Uniquement des ressources financières
  - B. Uniquement des ressources matérielles
  - C. Des ressources humaines, matérielles ou financières
  - D. Des ressources financières et des informations uniquement
38. Quelle est la première étape pour construire un partenariat ?
- A. Créer une vision commune de l'avenir
  - B. Identifier les partenaires
  - C. Déterminer les résultats souhaités du partenariat
  - D. Evaluer la situation actuelle
39. Quelle est la première étape de l'action communautaire ?
- A. Identification et priorisation des problèmes
  - B. Collecte et analyse des données sanitaires et communautaires
  - C. Programmation du projet
  - D. Suivi et évaluation
40. Quelle étape vient directement après la mise en œuvre du projet ?
- A. Suivi et évaluation
  - B. Collecte et analyse des données sanitaires et communautaires
  - C. Identification et priorisation des problèmes
  - D. Identification du projet communautaire





9. Maladie constamment présente dans une région donnée, est dite :  
A Epidémie C Sporadique  
B Pandémie D Endémie
10. Laquelle des maladies suivantes, est soumise au règlement sanitaire international :  
A Le trachôme  
B La diphtérie  
C Le paludisme  
D Le choléra
11. L'Etude de cohorte est :  
A Est adaptée pour étudier les maladies rares  
B Permet de déterminer directement l'incidence de la maladie chez les exposés et les non exposés  
C Toujours prospective  
D La validité des résultats peut être très affectée par les non répondants et les perdus de vue
12. Les résultats d'une enquête de cohorte révèle un RR=0.5 et un IC à 95% [0.3-0.7], quelle est l'interprétation qui convient ?  
A Facteur de risque, liaison significative  
B Facteur protecteur, liaison significative  
C Facteur de risque possible, mais liaison non significative  
D Facteur de protection possible, mais liaison non significative
13. Comment se répartissent les responsabilités dans la nouvelle gouvernance sanitaire ?  
A. Le ministère définit la politique nationale et exerce la tutelle  
B. Les GST gèrent les établissements publics de leur région  
C. La HAS administre directement les hôpitaux  
D. La HAS évalue la qualité et émet des recommandations
14. Quels principes en matière de qualité et sécurité des soins sont promus par la réforme ?  
A. L'instauration d'un référentiel national d'évaluation  
B. Exclusion du secteur public de la démarche qualité  
C. L'amélioration continue et la transparence des résultats  
D. Abrogation des audits sanitaires
15. Que prévoit la loi 09-08 pour le transfert international des données de santé ?  
A. Autorisation uniquement si le pays de destination offre une protection adéquate  
B. Encadrement juridique et autorisation CNDP nécessaires  
C. Dispense d'accord du patient  
D. Oui
16. Parmi les principes cardinaux explicitement posés par 06-22 :  
A. Équité d'accès et continuité des prestations  
B. Territorialisation de l'offre et réduction des inégalités spatiales  
C. Rattachement organique des hôpitaux aux communes  
D. Souveraineté et sécurité des médicaments/produits de santé
- Comment se répartissent les fonctions institutionnelles dans la réforme sanitaire ?  
A. MSPS : élabore la politique nationale, assure la tutelle et la régulation  
B. HAS : évalue la qualité et la sécurité des soins  
C. GST : gère les établissements publics régionaux et planifie l'offre  
D. Toutes les réponses sont justes
- Quelle est la hiérarchie juridique des normes dans le système de santé marocain ?  
Dahir de promulgation → Loi → Décret → Arrêté  
Circulaire → Loi organique  
Bulletin officiel : publication authentique des lois et décrets  
Présentations internes → Dahir royal





19. Quelle institution assure la coordination nationale de la stratégie de vaccination au Maroc ?
- A. Le ministère de l'intérieur
  - B. Un partenariat OMS-UNICEF
  - C. Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
  - D. Les agences régionales de pharmacie
20. En 2024, quelle initiative a été mise en œuvre pour renforcer la prise en charge dans les services d'urgences hospitalières ?
- A. Création de pôles de traumatologie dans plusieurs hôpitaux régionaux
  - B. Délocalisation des SAMU vers les capitales régionales
  - C. Réduction par décret des admissions non urgentes
  - D. Augmentation du nombre de cabinets privés d'urgence
21. Quelle problématique sanitaire constitue une priorité majeure dans la région Marrakech-Safi ?
- A. Maladies radio-induites
  - B. Accidents de la route et urgences traumatologiques
  - C. Infections nosocomiales exclusives
  - D. Maladies vectorielles rares
22. Quel est l'objectif principal du plan "Hôpital sans rendez-vous", lancé en 2023 ?
- A. Supprimer la médecine de famille
  - B. Soumettre l'offre hospitalière publique à des quotas
  - C. Faciliter l'accès des citoyens aux consultations spécialisées sans délai préalable
  - D. Limiter l'accès aux urgences vitales
23. Quelle structure nationale a été créée en avril 2025 pour améliorer la réponse aux urgences sanitaires ?
- A. Centre National d'Opérations d'Urgence en Santé Publique (CNOUSP)
  - B. Centre National de Coordination des Épidémies
  - C. Direction Générale de la Sécurité Sanitaire
  - D. Centre National de Prévention Médicale
24. À quoi sert un système d'alerte précoce sanitaire ?
- A. Détecter rapidement et signaler les menaces épidémiques émergentes
  - B. Centraliser les données des ambulances dans un centre logistique
  - C. Reporter les décisions sanitaires au niveau hospitalier
  - D. Organiser le transport interrégional des patients graves
25. L'initiative mondiale "Santé pour tous" de l'OMS a pour objectif principal :
- A. La privatisation des systèmes de santé
  - B. L'accès universel aux soins de santé essentiels et équitables
  - C. L'augmentation du coût des soins hospitaliers
  - D. La limitation des soins de base
26. En 2025, la part du financement public dans les dépenses de santé au Maroc représente environ :
- A. 38 %
  - B. 51 %
  - C. 60 %
  - D. 67 %
27. L'indicateur le plus pertinent pour évaluer l'efficacité des services d'urgence est :
- A. Le nombre de lits hospitaliers
  - B. Le taux d'occupation des salles d'attente
  - C. Le temps moyen de réponse préhospitalier
  - D. Le nombre d'ambulances régionales



26. Parmi les étapes de la lutte contre les déficiences visuelles en milieu scolaire, il y a :
  - A. Le dépistage par l'échelle métrique ;
  - B. La mesure de l'acuité visuelle par le réfractomètre automatique ;
  - C. L'appareillage des malvoyants
  - D. Le contrôle mensuelle de l'acuité visuelle après l'appareillage
27. Parmi les signes d'appel d'un trouble auditif (pour la surdité acquise) :
  - A. Retard de la parole et du langage
  - B. Difficultés d'apprentissages
  - C. Détérioration de la parole articulée
  - D. Modification du comportement, agressivité et frayeur surtout la nuit
28. La VMS en milieu universitaire par des professionnels travaillant dans le secteur public s'adresse obligatoirement aux cibles suivantes :
  - A. Tous les étudiants résidants et non résidants de la première année des études universitaires (public)
  - B. Tous les étudiants résidants et non résidants de toutes les années des études universitaires (public)
  - C. Aux étudiants des établissements de l'enseignement privé
  - D. Le personnel de cuisine et de service des cités et résidences universitaires et buvettes (public).
29. Le déroulement du Counseling dans le dépistage précoce du cancer du col et de l'utérus (DPCCU) se fait au niveau du centre de santé (CS) lors du recrutement par les éléments suivants :
  - A. Bien accueillir la participante
  - B. L'informer sur le programme
  - C. Lui expliciter clairement l'intérêt à gagner en adhérant au programme
  - D. Lui proposer le test IVA et lui expliquer que le test est un examen rapide (5 à 10 mn), simple, indolore et le résultat est immédiat.
30. Si le test IVA est négatif :
  - A. Expliquer à la participante que le résultat du test est normal
  - B. Ne pas expliquer à la participante que le résultat du test est normal
  - C. La sensibiliser sur l'importance et l'intérêt de l'observance de la périodicité du dépistage tous les 2 ans
  - D. La sensibiliser sur l'importance et l'intérêt de l'observance de la périodicité du dépistage tous les 3 ans
31. Si le test IVA est positif ou non concluant (JPS invisible) :
  - A. Expliquer à la participante que le résultat est suspect
  - B. Ne pas expliquer à la participante que le résultat est suspect
  - C. L'orienter vers le centre de référence « CRSR » pour bénéficier d'un examen approfondi sous colposcopie par un gynécologue
  - D. L'orienter vers le centre de référence « CRSR » pour bénéficier d'un examen approfondi sous colposcopie par un médecin radiologue
32. Dans l'approche de la prise en charge de l'enfant aux urgences, le triangle d'évaluation pédiatrique comporte :
  - A. L'apparence
  - B. La respiration
  - C. La circulation
  - D. Le mouvement
33. Par rapport aux éléments du triangle d'évaluation pédiatrique, le « TICRL » signifie :
  - A. Toucher / Interaction / Contraction / Regard / Langage
  - B. Toucher / Intervention / Consolabilité / Réaction / Levé
  - C. Tonus / Intervention / Contrôle / Regard / Langage
  - D. Tonus / Interaction / Consolabilité / Regard / Langage





34. Par rapport à la fréquence respiratoire des enfants, lesquelles des propositions suivantes sont fausses :
- A. < 1 an : 30 - 53
  - B. 1 - 2 ans : 28 - 45
  - C. 6 - 11 ans : 25 - 35
  - D. 12 - 15 ans : 12 - 20
35. Pour les non professionnels, la reconnaissance de l'ACR est simple et repose sur l'absence de signes de vie :
- A. Victime inconsciente.
  - B. Pas de mouvements.
  - C. Pas de réaction.
  - D. Pas de respiration ou respirant de façon anormale.
36. Dans la réanimation Cardiorespiratoire (RCP) de base, l'acronyme « 3 S » signifie :
- A. Stabilité / Simulation / Appel au Secours
  - B. Sécurité / Simulation / Appel au Secours
  - C. Sécurité / Stimulation / Appel au Secours
  - D. Stabilité / Simulation / suivi
37. Dans la réanimation Cardiorespiratoire (RCP) de base, l'acronyme « A B C » signifie :
- A. Airway / Breathing / Circulation
  - B. Airway / Breathing / Care
  - C. Assistance / Breathing / Caring
  - D. Assistance / Breathing / Circulation
38. Parmi les premiers gestes devant le coma, il faut :
- A. Assurer la liberté des voies aériennes et la mise en place d'une canule de Guédel
  - B. Assurer l'oxygénothérapie, l'intubation et la ventilation si GCS < 8.
  - C. Assurer un abord vasculaire
  - D. Veiller à la correction des troubles hémodynamiques
39. Pour la stérilisation, l'étape de « séchage » se fait dans :
- A. La zone de lavage
  - B. La zone propre
  - C. La zone stérile
  - D. Toutes les réponses sont justes
40. L'introduction des vaccins contre le Pneumocoque et le Rotavirus au Maroc c'était en :
- A. 2008
  - B. 2010
  - C. 2012
  - D. 2016